

CAPÍTULO 3

Introducción

*Sergio Zanassi, Jesuán Agrazar
y Martina Fernández Raone*

*Esto quiere decir que el paradigma previo
respecto al nuevo no muestra
ni un error puro y simple ni una aberración,
sino la simple obsolescencia
y el no estar capacitado ya
para resolver los enigmas que, sin embargo,
ha contribuido a formular (...)
el nuevo paradigma no destruye
realmente al anterior,
el cual, discretamente y dentro de su ámbito
puede prestar aún algunos servicios.
Georges Lantéri-Laura (2000)*

Una periodización posible

A partir de nuestro interés por recuperar los aportes que la psiquiatría clínica clásica ha realizado al psicoanálisis y a la salud mental, en esta parte del libro nuestro objetivo es poder delimitar y caracterizar sucintamente los hitos fundamentales que jalonan a la historia de la psiquiatría en sus definiciones de la patología mental.

Se trata entonces de reconstruir el contexto en el que las primeras concepciones acerca del padecimiento mental se fueron gestando. Recordemos que la psiquiatría -del griego ψυχή, [*psyche*]: alma, y ἰατρέω [*iatreía*]: curación- no se constituye como disciplina científica a partir de la especialización de saberes acumulados de la medicina, sino que su conformación inaugural responde a urgencias coyunturales de un contexto socio-histórico y político determinado: el de la revolución francesa y la extensión del estatuto de sujeto de derecho a todos los ciudada-

nos.⁵ A partir de su surgimiento a finales del siglo XVIII en Europa, la historia de la psiquiatría estuvo signada por diversos puntos de inflexión que dieron lugar a modificaciones cruciales, tanto a nivel teórico como empírico y metodológico.

El abordaje propuesto no es una tarea sencilla, puesto que -como ya hemos visto en la primera parte- está atravesado por una microfísica del poder que impacta en la constitución de los saberes. Para adentrarnos en él retomaremos lo elaborado por uno de los historiadores de la psiquiatría cuyo trabajo ha obtenido mayor reconocimiento: Georges Lantéri-Laura, y cuyas formulaciones han sido retomadas en otros estudios sobre la materia, como los de Bercherie, Álvarez, Stagnaro y Napolitano, por sólo mencionar algunos.

Este autor propone una periodización de la historia de la psiquiatría a partir de la utilización del concepto de paradigma de Kühn y reconoce que la historia de la psiquiatría no puede ordenarse desde una "ilación unilineal y continua" (Lantéri-Laura, 2000: 37), sino que se trata de una franca yuxtaposición de datos que son discontinuos entre sí y que se dan en determinado espacio y tiempo: Europa occidental, especialmente Francia y Alemania -a fines del s. XVIII y principios del s. XIX-. Estas elaboraciones europeas impactaron en las incipientes concepciones del padecimiento mental que se fueron imponiendo en nuestro país, de ahí el interés de adentrarnos en ellas.⁶

La importancia de introducir algún tipo de ordenamiento en este conjunto heterogéneo y discontinuo de informaciones radica en que una periodización puede permitir "ordenar racionalmente el conjunto de datos empíricos que constituye la materia del historiador" (Klappenbach, 2006: 110). Por lo tanto, no es nuestra intención realizar una lectura cronológica "pura" de la historia de la psiquiatría, sino centrarnos en los movimientos y discontinuidades que en ella se han producido, entendiendo a la misma como un campo de saber-poder.

Lantéri-Laura destaca que los movimientos señalados en la historia de la psiquiatría no responden a la idea de una totalidad y una continuidad acabadas:

(...) el estudio concreto de la historia de la psiquiatría nos muestra que no fluye como un flujo heraclítico continuo desde sus orígenes, sino que tiene lugar a base de franjas de tiempo en las cuales todo aquello que le concierne parece repetirse, desarrollarse sin cambios y vivir a base de recurrencias y repeticiones más que de modificaciones efectivas (Lantéri-Laura, 2000: 43).

Así, la periodización queda definida por determinada franja de temporalidad durante la cual ciertos elementos sufren pocas modificaciones y las recurrencias son más importantes que los cambios. En cada uno de los períodos delimitados por Lantéri-Laura veremos cómo ciertas concepciones centrales no sufren mayores alteraciones hasta que las mismas entran en crisis y marcan una discontinuidad. Otros autores no delimitan los períodos de la psiquiatría a partir de la noción de paradigma, sino que diferencian dentro de la disciplina a determinados exponentes y momentos históricos que se han ocupado de la clínica del

⁵ Cf. capítulo 1 de este libro.

⁶ Cf. capítulo 2.

campo de la patología mental y que han colaborado para la construcción del edificio psiquiátrico (Álvarez, 2004; Bercherie, 1980).

Así, la psiquiatría se configura, por un lado, como un conjunto de teorías sistematizadas en un cuerpo de conocimiento y, por el otro, como fundamento de una futura psicopatología, cuyo surgimiento es posterior y que cimienta sus bases en la concepción de la locura en sus diversas acepciones.

De este modo, debemos tener en cuenta que la modalidad de abordaje, descripción, clasificación y tratamiento de las patologías en el campo de lo mental fueron sufriendo cambios en el curso del desarrollo de la psiquiatría. El método de observación de los fenómenos mórbidos, las hipótesis etiológicas⁷ subyacentes a cada presentación y su nosografía,⁸ así como el papel del psiquiatra en el estudio de la locura fueron precisados según el marco conceptual que caracterizaba a un determinado paradigma.

La noción de paradigma, acuñada y sistematizada por Thomas Kühn en su libro *La estructura de las revoluciones científicas* (1962) es una herramienta conceptual que nos permite analizar tres períodos de la psiquiatría, tal como propone Lantéri-Laura (2000).

Kühn, en función de su perspectiva epistemológica, entiende a la ciencia como una actividad puramente racional, y a su vez, como una actividad concreta que se ha dado durante siglos y que en cada momento histórico presenta diferentes particularidades y características que le son propias.

El **paradigma** es un conjunto de conocimientos, un marco conceptual, organizador de lo perceptual, que en determinado momento de ciencia normal sirve de referencia fundamental y eficaz para la resolución de los problemas que se plantean en su interior. El paradigma es entonces una suerte de consenso dentro de una comunidad científica que involucra “toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etc. compartidos por los miembros de una comunidad dada” (Kühn, 1962: 269).

Un paradigma que no está en crisis permite explicar de manera satisfactoria un gran número de fenómenos. Kühn afirma que las teorías que se inscriben en un paradigma no pueden traducirse en términos de las proposiciones que forman el paradigma posterior, por lo tanto esto hace que los paradigmas sean inconmensurables.

Por otra parte, cada paradigma puede entrar en una llamada “**crisis**”. Este término implica la puesta en duda y cuestionamiento a los que son sometidos los fundamentos que sostenían al paradigma vigente y que pueden dar lugar al surgimiento de un nuevo paradigma que permita resolver los problemas que el anterior no resolvía. En consonancia con este planteo, en el que los conceptos de ciencia normal, crisis y revolución se vinculan estrechamente, Kühn considera a la revolución científica como un cambio total de la percepción del mundo.

⁷ El concepto de etiología refiere al estudio de las causas de una enfermedad. En medicina, con respecto a la causa, se diferencia entre etiología y patogenia. La primera corresponde al estudio de las causas en términos del origen último de la enfermedad, su procedencia; mientras que la patogenia refiere a los mecanismos de acción por los cuales se desarrolla la enfermedad a partir del contacto con el agente etiológico. Mientras que la etiología refiere a las razones últimas de la enfermedad, la patogenia se ocupa del estudio de la forma en que la etiología lleva al desarrollo de la enfermedad.

⁸ La nosografía -del griego *nosos* enfermedad y *grapho*, descripción- es la descripción y clasificación de las patologías. La nosografía está incluida dentro de la nosología, rama de la medicina que busca denominar, definir, explicar y diferenciar a las entidades mórbidas.

Es interesante destacar que el paradigma no es algo meramente abstracto, sino que organiza lo que percibimos. La observación no es pura, sino que está organizada por nuestras concepciones. “Lo que un hombre ve depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha preparado a ver” (Kühn, 1962).

Lantéri-Laura (2000) retoma la concepción de Kühn, con ciertas salvedades,⁹ y entiende al paradigma en los siguientes términos: “conjunto de representaciones coherentes y correlacionadas entre sí, que regulan durante largo tiempo, de manera racional, eficaz y económica, la disciplina cuyo paradigma precisamente constituyen.” (p. 48). Las modalidades que adquiere el estatuto de lo normal y lo patológico en cada momento histórico confieren a la práctica psiquiátrica preceptos que orientan e inscriben a cada integrante de la comunidad científica en un discurso consensuado.

Ahora bien, los paradigmas -en tanto regulaciones de los conocimientos en determinado período- entran en crisis y son sustituidos por otros, sin que esto signifique que este pasaje se produzca de un momento a otro, ni que el paradigma previo desaparezca, sino que queda en un segundo plano, latente, larvado.

Los paradigmas previos sobreviven y sus ideas pueden reaparecer efectivamente en el seno de los nuevos paradigmas, aunque no lleguen a recobrar ese poder de regulación de los conocimientos y las prácticas que poseían antes de entrar en crisis. Cada nuevo paradigma implica un cambio de enfoque sobre el hecho psiquiátrico. Enfatizamos así que no hay *una* definición de la patología mental, sino que ésta cobra diferentes formulaciones de acuerdo al paradigma en que la encontremos.

Lantéri-Laura contribuye a delimitar tres paradigmas en la historia de la psiquiatría: el de la alienación mental, el de las enfermedades mentales y el de las grandes estructuras psicopatológicas. Deja abierta la pregunta de “si la consideración de un cuarto paradigma puede ser una empresa razonable o no” (Lantéri-Laura, 2000: 245). Esta distinción es retomada y reconocida por muchos historiadores en la materia, de ahí la importancia de conocerla.

En adelante, nos ocuparemos de deslindar las principales formulaciones, alcances, criterios y vigencia de cada uno de estos paradigmas de la psiquiatría.

Los operadores de lectura que privilegiaremos en el análisis de cada paradigma son:

- el método, es decir el procedimiento ordenado y sistemático que se utilizó para describir los fenómenos patológicos en el ámbito mental.
- la concepción del padecimiento psíquico: salud-enfermedad, síntomas y signos.
- las hipótesis sobre las causas, etiología y patogenia.
- los tipos de tratamientos propuestos.

Veremos en el recorrido cómo estos cuatro ítems guardan una coherencia interna en cada uno de los paradigmas.

⁹ Lantéri-Laura aclara que, a diferencia de los casos estudiados por Kühn, los paradigmas de la psiquiatría entran en crisis y se suceden con mucha mayor rapidez que los de la física: en menos de un siglo se suceden tres paradigmas en la historia de la psiquiatría.

Referencias bibliográficas

- Álvarez, JM, Esteban, R., Sauvagnat, F. (2004). *Fundamentos de psicopatología psicoanalítica*. Madrid: Síntesis.
- Bercherie, P. (1980). *Los fundamentos de la clínica: historia y estructura del saber psiquiátrico*. Buenos Aires: Manantial, 2014.
- Klappenbach, H. (2006). Periodización de la psicología en Argentina. *Revista de Historia de la Psicología*, 27 (1),109-164.
- Kühn, S. (1962). *La estructura de las revoluciones científicas*. México: Fondo de cultura económica, 2007.
- Lantéri-Laura, G. (2000). *Ensayo sobre los paradigmas de la psiquiatría moderna*. Madrid: Editorial Triacastela.
- Napolitano, G. (2000). *El nacimiento de la psicopatología*. La Plata: Ed. La campana.

CAPÍTULO 4

Primer paradigma: la alienación mental

(1793-1854)

*Sergio Zanassi, Jesuán Agrazar
y Julieta De Battista*

*Los alienados, lejos de ser culpables
a los que se necesita castigar,
son enfermos cuyo penoso estado
merece todas las consideraciones debidas
a la humanidad sufriente y respecto de los cuales
uno debe intentar, por los medios más simples,
restablecerles la razón perdida.*

Pinel, 1809.

Pinel y la primera psiquiatría clínica

En este apartado presentamos el paradigma de la alienación mental, tal como lo ha elaborado Lantéri-Laura (2000). Nos orientamos también con el aporte teórico de distintos autores que han trabajado esta temática.¹⁰ Lantéri-Laura propone un año de inicio y un año de crisis tentativos para enmarcar este primer período, sin que eso suponga entender que estos cortes en el tiempo son taxativos. La designación de Pinel en el Hospicio de Bicêtre en el año 1793 marca el inicio de este primer paradigma que comienza a entrar en crisis entre 1850 y 1860, más precisamente en 1854 cuando Falret publica las primeras críticas a la concepción de la patología mental como afección unitaria. Sin embargo, los cambios no se dan de manera inmediata y el vocabulario del primer período persistió por mucho tiempo. La diferencia entre la noción social de locura y la locura como enfermedad a tratar -establecida en este paradigma-, sigue vigente hoy en día.

¹⁰ Nos referimos al libro de Michel Foucault *El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica*, cuya primera edición en francés es de 1963; la tesis de doctorado de Paul Bercherie -discípulo de Lantéri-Laura, titulada *Los fundamentos de la clínica. Historia y estructura del saber psiquiátrico*, publicada por Navarin en 1980; y al texto de Napolitano sobre el nacimiento de la psicopatología. Cada una de estas fuentes tiene sus aportes y sus limitaciones. Por ejemplo, el texto de Bercherie acepta como límite de su trabajo el haber dejado sistemáticamente de lado en su indagación los aspectos institucionales y sociales de la historia de la clínica; que Foucault, en cambio, considera primordiales en su abordaje, posición que acompañamos en este libro (Cf. con el capítulo 1).

El nombre de este primer paradigma señala la concepción subyacente. La palabra "alienación" proviene etimológicamente del latín *alienus*, que quiere decir "ajeno", que pertenece a otro. Este paradigma se define por la concepción establecida de la alienación mental como un término propiamente médico referido a una afección única, específica y autónoma, que debe separarse de las demás enfermedades de la medicina y que hay que distinguir de la representación social de la locura.

Esta primera operación de **medicalización de la locura** inscribe a la patología mental en el campo de la medicina, al intentar explorar "qué es lo que puede considerarse como propiamente médico en todo lo que, de forma tal vez intuitiva, se concibe de modo amplio, aunque incierto, bajo esta denominación de *locura*" (Lantéri-Laura, 2000: 74). Por primera vez entonces, se propone distinguir entre aquello que social y culturalmente se entiende por locura y aquello que la ciencia médica nombra como alienación mental a partir del examen riguroso y metódico de los enfermos. Se separa así la patología mental de otras conductas calificadas como "anormales" y también de otras enfermedades que no obedecen a un padecimiento psíquico.

De este modo, es importante destacar que esta inscripción de la patología mental en el campo de la medicina se da sobre un fondo en el cual ya existen presupuestos sociales y culturales acerca de la locura, es decir que ya hay una representación social de la locura que precede a su medicalización (Lantéri-Laura, 2000: 16-17). En cada sociedad existe cierto sentido común acerca de qué es "estar loco".

Iniciamos este recorrido recordando que el relato mítico más reconocido de Pinel lo ubica en la historia como el gran liberador de los alienados, aquel al que se le atribuye el gesto de haberlos transformado en enfermos que requieren de asistencia, diferenciándolos así de los indigentes, los delincuentes y otros personajes que caían sin distinción bajo la órbita de la justicia. El gesto que inicia la "gesta" pineliana se acompaña de un cambio de denominación, los otrora insensatos son llamados ahora "alienados".¹¹ Esto implicaría grandes beneficios, ya que la noción social de locura, según Pinel, "puede tener una amplitud indeterminada y extenderse a todos los errores y extravagancias de que es susceptible la especie humana, lo que, merced a la debilidad del hombre y a su depravación, no tendría límites." (Lantéri-Laura, 2000: 75). En cambio, la concepción de la alienación mental delimita una patología propiamente médica y a su vez diferente de las otras enfermedades tratadas por la medicina de entonces.

Como ya hemos trabajado en la primera parte de este libro, el surgimiento de la psiquiatría como especialidad dentro de la medicina se encuentra estrechamente ligado a un cambio sobre la consideración de la locura, que implica una nueva perspectiva sobre el loco, considerado a partir de ahora como enfermo, es decir, como alienado mental. Se produce una innovación y una verdadera ruptura ideológica en la cual cobra relevancia la consideración de la noción de sujeto de derecho. El nuevo régimen social y jurídico no excluye sino que afirma la permanencia del sujeto. De esta manera, los inicios de la psiquiatría no pueden ser meramente atribuidos al gesto liberador de Pinel, sino a las respuestas que se dieron ante la urgencia histórica que implicó la revolución francesa y que derivó en la incorporación de la locura dentro del campo de

¹¹ Véase una lectura crítica de esta versión mítica en el capítulo 1.

la medicina, concibiéndola desde entonces como una enfermedad que requería un tratamiento especializado.

El método clínico

Pero este gesto mítico de liberación -inmortalizado por la pintura de Müller en la que se puede ver a Pinel ordenando que se corten las cadenas-, conlleva el riesgo de agotar la figura de este pionero en sus principios filantrópicos y olvidar que fue también el iniciador de la aplicación del método clínico en psiquiatría. La medicina de entonces se basaba en el *corpus hippocraticum* y su teoría de los humores: una teoría explicativa general y especulativa. El método clínico en medicina, en cambio, produce la novedad de dejar a un lado los sistemas explicativos para abocarse al examen del enfermo, observar los datos empíricos de la enfermedad -aquellos a los que se puede acceder a través de los sentidos, especialmente de la mirada-, para luego describirlos sistemáticamente.

El término "clínica" viene del latín *clinicus*, que a su vez reconoce su ascendencia del griego *klinikós* que quiere decir "que visita al que guarda cama", deriva de *Kliné*, cama. En medicina, el método clínico comenzó a utilizarse sistemáticamente en el siglo XVIII, con el surgimiento de la medicina moderna que dejó a un lado las numerosas teorías acerca del padecer para dedicarse al examen directo del enfermo en su lecho, mediante la observación minuciosa de los fenómenos patológicos.¹²

Se trata de un método que pone en primer lugar a la mirada del médico sobre el enfermo y que Foucault (1963), en su obra *El nacimiento de la clínica*, califica como el ejercicio del "poder soberano de la mirada empírica" (p. 7). Esta obra de Foucault es prácticamente contemporánea de la de Kühn, por lo tanto no podemos esperar que Foucault se ocupe de los paradigmas de la historia de la psiquiatría. Por otra parte, no han sido esos los términos en que ha planteado su estudio de la constitución del saber médico. No obstante, se pueden distinguir en esta obra de Foucault características propias de esos primeros consensos en el campo del saber psiquiátrico, que nos interesa retomar.

En *El nacimiento de la clínica*, cuyos principales argumentos revisaremos en lo que sigue, Foucault señala que el método clínico permitió fundar un nuevo objeto de estudio para la medicina moderna: abordar el sufrimiento de un individuo a partir de esta mirada positiva sobre el cuerpo del enfermo. Este movimiento es novedoso históricamente, en tanto ya no se trata de teorías generales acerca del padecer, sino que se recorta al individuo enfermo como objeto de investigación: un sujeto puede convertirse en objeto de un discurso.

La mirada no es ya reductora, sino fundadora del individuo en su calidad irreductible. Y por eso se hace posible organizar alrededor de él un lenguaje racional.

¹² Remitimos al lector a la obra de Foucault sobre el nacimiento de la clínica. La utilización del método clínico en psicoanálisis es trabajada por Lombardi en su libro *El método clínico*, publicado en Buenos Aires por Paidós.

El *objeto* del discurso puede bien ser así un *sujeto*, sin que las figuras de la objetividad, sean, por ello mismo, modificadas. Esta reorganización *formal* y *de profundidad*, más que el abandono de las teorías y de los viejos sistemas, es la que ha abierto la posibilidad de una *experiencia clínica*; ha retirado el viejo entredicho aristotélico: se podrá al fin hacer sobre el individuo un discurso de estructura científica. (Foucault, 1963: 8)

Sin dudas esta innovación no hubiese sido posible sin los avatares descriptos en la primera parte de nuestro libro: extensión del estatuto de sujeto de derecho a todos por igual y aislamiento de aquellos que padecían de alienación mental. Este aislamiento en los hospitales, el alojamiento de los padecientes en sus camas, posibilita el acceso al individuo enfermo concreto.

En esta microfísica del poder se delimitan los cuerpos enfermos alojados en los lechos de los hospitales como objeto de la mirada positiva del médico. Por primera vez, señala Foucault, se puede establecer un discurso científico sobre el individuo enfermo y no sobre las generalidades teóricas de las enfermedades. Esta mirada del médico funda al individuo enfermo como objeto y es condición de posibilidad de la experiencia clínica como "apertura del individuo concreto al lenguaje de la racionalidad (...) El lecho del enfermo se convierte en campo de investigación y de discursos científicos." (Foucault, 1963: 8-9)

Ahora bien, Foucault subraya que esta mirada del médico sobre el cuerpo del enfermo requiere además de la construcción de una lengua para transmitir lo que esa mirada recoge. El método clínico lleva implícita una tendencia al nominalismo, a dar nombre a aquello que se observa, a transformar el sufrimiento en un discurso racional.

La experiencia clínica es una manera de ver, pero sobre todo es una manera de decir. El objeto del sufrimiento mental individual iluminado por la mirada del médico necesita trasponerse en un discurso de estructura científica, requiere una articulación con el lenguaje médico que inaugura una "verbalización fundamental de lo patológico" (Foucault, 1963: 4): "La mirada que recorre un cuerpo que sufre, no alcanza la verdad que busca sino pasando por el momento dogmático del *nombre*" (Foucault, 1963: 93).

De ahí que esta experiencia no sea del orden de lo inefable, sino que se acompaña de la creación de toda una nomenclatura acerca del sufrimiento mental. Se sigue de esta manera el precepto de Condillac que entiende a la ciencia como una lengua bien hecha. Es primordial acceder a través de la mirada a las manifestaciones de lo patológico, pero más aún es poder nombrar las categorías obtenidas por la observación empírica. El trabajo de Pinel se caracteriza entonces por una confianza en la observación y una desconfianza en la teoría, y las críticas que ha recibido recaen justamente en que supone una observación "pura", no atravesada por principios teóricos.

¿Qué es lo que de esta experiencia se intenta nombrar? Veremos cómo esta nominación va de la mano de la concepción de enfermedad que atraviesa este momento de elaboración del saber psiquiátrico.

La enfermedad y los síntomas

Foucault plantea que en la tradición médica del siglo XVIII hay una concepción pregnante acerca de la enfermedad por la cual se supone que no puede accederse a ella a través de los sentidos: la esencia de la enfermedad escapa a la aprehensión de los sentidos, no se la puede captar por la mirada, es inaccesible. Lo que se presenta de la enfermedad al observador son los síntomas. El **síntoma** es entendido entonces en esta época como "la forma bajo la cual se presenta la enfermedad: de todo lo que es visible, él es el más cercano a lo esencial; y es la primera transcripción de la naturaleza inaccesible de la enfermedad" (Foucault, 1963: 131).

La enfermedad no es accesible por los sentidos, el médico accede a los síntomas de la enfermedad, pero no a la esencia de la enfermedad en sí. Aquello que puede observar son las manifestaciones de la enfermedad, la forma que ésta tiene de presentarse en los síntomas: "Los síntomas dejan transparentar la figura invariable, un poco en retirada, visible e invisible, de la enfermedad" (Foucault, 1963: 131).

Son síntomas que Foucault califica de "**subjetivos**", en tanto el médico accede a ellos a través del relato que el enfermo realiza de los mismos en respuesta a la pregunta "¿Qué tiene usted?" Los síntomas en este momento de la psiquiatría son entonces aquello que se enuncia espontáneamente sobre la enfermedad, el relato de la experiencia del enfermo, sus confidencias y la observación de sus comportamientos.

Pinel otorga la mayor importancia a los **síntomas más notorios**, más pintorescos, más llamativos, aquellos que presentaban la mayor extensión en el relato de la enfermedad: "el síntoma era más elocuente o más seguro cuanto más superficie tenía en las manifestaciones de la enfermedad" (Foucault, 1963: 227- 229; Bercherie, 1980: 19). Las descripciones de esa época abundan en caracterizaciones espectaculares de la alienación: síntomas muy notables, ruidosos, comportamientos bizarros, excesos de las pasiones.

En este momento, el método de observación clínica no recurre al uso de instrumentos que permitan medir ese malestar de una manera "objetiva", sino que se basa en la expresión del malestar que el propio enfermo refiere. De ahí que para Foucault, la mirada clínica de este primer momento sea una "mirada botánica", una mirada de jardinero, que busca reconocer en las distintas formas de presentación del malestar la esencia específica de la alienación mental, en su diferencia con otras enfermedades médicas.

Esta mirada es entonces una mirada fuertemente ligada al caso como ejemplo. El individuo enfermo se vuelve un "caso", una forma de presentación de esta esencia inaccesible de la enfermedad:

En el hospital, el enfermo es *sujeto* de su enfermedad; es decir que se trata de un caso; en la clínica, en la cual no se trata sino del *ejemplo* del enfermo, es el accidente de su enfermedad, el objeto transitorio del cual ésta se ha apropiado. (Foucault, 1963: 92).

Esta noción de la **enfermedad como accidente**, como fuerza que desde el exterior perturba el equilibrio del organismo es propia de este período y sufre modificaciones en el paradigma siguiente. De estos casos individuales puede extraerse un saber acerca de las manifestaciones patológicas en la medida en que las mismas puedan traducirse en un lenguaje claro y ordenado de los síntomas, "la mirada clínica opera sobre el ser de la enfermedad una reducción nominalista" (Foucault, 1963: 171). Este lenguaje de los síntomas puede transmitirse y enseñarse a otros médicos, convirtiendo a esta esencia inaccesible de la enfermedad en una nominación posible de los síntomas bajo los cuales aparece.

Sin dejar de tener presente que la alienación mental constituye por sí misma una única y autónoma enfermedad, Pinel organiza esta primera psiquiatría clínica distinguiendo cuatro especies dentro del género único de la alienación mental. Estas especies son distintos aspectos bajo los cuales puede manifestarse la alienación mental, y no constituyen formas clínicas diferenciales, sino aspectos de una única alienación (Lantéri-Laura, 2000: 78).

Recordemos que en este paradigma lo primordial es distinguir a la patología mental de otras enfermedades médicas y por lo tanto esta unidad es necesaria para sostener la importancia de un conocimiento y un tratamiento específico. El examen clínico psiquiátrico se aboca entonces a registrar las alteraciones de las distintas facultades de la mente: la percepción, la memoria, el juicio, la sensibilidad, la afectividad. De esta manera Pinel, y su discípulo Esquirol, distinguen cuatro especies o variedades de manifestación de la alienación mental: la monomanía o manía, la melancolía o lipemanía, la demencia y la imbecilidad o idiocia.

La **monomanía o manía** es una especie en la cual el delirio es general y las facultades del entendimiento se hallan lesionadas en su mayoría. Se acompaña de excitación y estados de furor con predominio de una pasión alegre y expansiva.

La **lipemanía o melancolía** es un delirio parcial, limitado a un objeto o a un pequeño número de ellos, con predominio de una pasión triste y depresiva.

La **demencia** queda definida por una abolición de la razón, que obedece a que las facultades mentales han perdido su energía y ya no llevan a cabo sus funciones, sino que se manifiestan en la incoherencia a nivel de todas las facultades.

La **imbecilidad o idiocia** se diferencia de esta última porque los órganos nunca pudieron razonar adecuadamente por defectos de nacimiento, las facultades intelectuales directamente no han podido desarrollarse. La figura que utiliza Esquirol para diferenciar al demente del idiota es la del hombre rico que se ha hecho pobre, para el primer caso, y la del hombre que siempre vivió en el infortunio y la miseria, en el caso del idiota (Lantéri-Laura, 2000: 91-94).

Vemos así cómo, a pesar de la insistencia en la **unidad de la alienación mental**, las formas de volverse alienado difieren notablemente entre las notas de las pasiones alegres, tristes y la pérdida o la abolición de la razón. No obstante, esto que pareciera ser un primer esbozo de diferenciación no se consolida como tal. No hay siquiera un inicio de semiología¹³ en la obra de

¹³ La semiología es el estudio de los signos -manifestaciones objetivas de la patología- y síntomas -percepción subjetiva- de las enfermedades.

Pinel, tampoco en la de Esquirol. Para que una semiología se constituya es necesario identificar diferencias entre signos que remitan a patologías distintas e irreducibles entre sí.

En la medida en que la alienación mental es una afección unitaria y única no existe la posibilidad de que una semiología decante: "toda la clínica [de Pinel], por viva y evocadora que nos parezca, se halla constituida por breves historias, apuntes o incluso resúmenes breves y sugestivos, pero sin que un elemento discreto presente en un caso aparezca de forma idéntica en otro." (Lantéri-Laura, 2000: 94). Las cuatro especies de la alienación mental, las cuatro formas en las que puede manifestarse esta alienación no son cuadros clínicos irreducibles entre sí, de hecho pueden aparecer sucesivamente en el mismo enfermo.

La clínica de Pinel es una **clínica sincrónica y sindrómica**, observa las manifestaciones de la patología mental haciendo un corte en el tiempo, para describir aquellos aspectos estáticos de un fenómeno, con exclusión de toda intervención del tiempo. No tiene en cuenta la sucesión de estados ni la evolución de la enfermedad, en tanto lo que interesa establecer es si el paciente se encuentra afectado de alienación mental o no, si está o no está loco en un momento dado. Esta idea de la locura como estado, ligada a comportamientos bizarros, persiste en el sentido común hoy en día: alguien está o no está loco.

Por otra parte, es importante aclarar que si bien algunos de los términos utilizados por Pinel y Esquirol aún existen en la actualidad -como por ejemplo, manía, demencia y melancolía-, no puede deducirse de esto que la manía descrita por Pinel se corresponda con lo que actualmente entendemos por manía. Así lo explicita Bercherie (1980): "Subrayemos enseguida el error profundo que constituiría toda tentativa de identificar estas categorías, puramente sintomáticas, con nuestras entidades actuales. Los términos que sobrevivieron podrían fácilmente inducir al error (...) Pinel, naturalmente, vio *todo*, pero no con *nuestra* mirada." (p.19).

Son estas concepciones del método clínico, de la enfermedad y de los síntomas las que subyacen al mítico gesto pineliano de separar a la alienación mental de otras enfermedades médicas. Pinel promovió un conocimiento del hombre basado en la observación y registro de los síntomas. Realizó una clasificación de las enfermedades y sus síntomas proponiendo un camino empírico. En este sentido, una de las finalidades del médico era observar los síntomas de los pacientes, considerados como el fenómeno patológico que se presenta en el enfermo por excelencia, lo observable y aquello que sobresale en la enfermedad.

Pinel no se detiene en realizar una semiología detallada, por el contrario, considera que la alienación mental está conformada por una gran clase sindrómica. Es desde esta perspectiva que la nosografía que realiza es en razón de los síntomas más notorios.

Pinel fue también un acérrimo defensor del método clínico en psiquiatría y es reconocido como el fundador de esta tradición en esta rama del saber. Es importante aclarar, no obstante, que este abordaje de la alienación mental no era el único en ejercicio en ese momento, otros psiquiatras empleaban otro método que adquiere relevancia en el segundo paradigma: el método anatomoclínico. Pinel no se valía de los datos anatomopatológicos en sus descripciones, pues consideraba al método clínico como soberano y las autopsias que había realizado no le habían resultado de utilidad en el esclarecimiento de la patología mental. Así, a su "desconfian-

za" en los sistemas explicativos se sumaba una desconfianza en los aportes de la anatomía patológica (Bercherie, 1980: 23-24).

Las causas morales

Este rechazo del método anatomopatológico se acompañaba sin embargo de una tesis etiológica por la cual, en última instancia, la alienación mental era causada por un desarreglo de la facultades cerebrales, aunque la anatomía patológica no pudiera demostrarlo fehacientemente. Se suponía que la sede última de la alienación mental estaría en el cerebro, ya que las funciones del alma se asociaban al funcionamiento de este órgano, aunque los descubrimientos de la anatomía patológica aún no eran tan preponderantes como lo serán en el paradigma siguiente. De ahí que Pinel enfatice la importancia de las denominadas "causas morales", entendidas como el impacto que las pasiones humanas producen en el organismo, al afectar al cuerpo funcionalmente, sin provocar una lesión orgánica.

En este momento del saber psiquiátrico se consideraba que un órgano podía estar afectado de tres maneras: en forma **idiopática** -el proceso mórbido afecta directa y exclusivamente al órgano, el origen del proceso es oscuro o desconocido-, en forma **sintomática** -el proceso mórbido se inició en otro órgano, pero afecta secundariamente a otros que se convierten en síntomas de ese proceso-, y en forma **simpática** -el órgano afectado primariamente incide en otros órganos con los cuales guarda relaciones de afinidad- (Lantéri-Laura, 2000: 99). Así, las pasiones excesivas podían influir causalmente en el cerebro por las conexiones simpáticas entre órganos.

Esta concepción es tangible en la organización que Pinel realiza de los casos para su transmisión, como por ejemplo el siguiente relato de manía sin delirio con acceso de furor:

Un hombre que se dedicaba antes a un arte mecánico y fue encerrado después en Bicêtre, sufre por intervalos irregulares de accesos de furor marcados por los siguientes síntomas: primero, un sentimiento de ardor candente en los intestinos, con una sed intensa y una fuerte constipación; este calor se propaga gradualmente al pecho, al cuello, a la cara con colores más animados, llevado a las sienes, se vuelve todavía más vivo y produce latidos muy fuertes y muy frecuentes en las arterias de esas partes, como si fueran a romperse; finalmente, la afección nerviosa gana el cerebro, y entonces está dominado por una inclinación sanguinaria irresistible, y si puede alcanzar un instrumento cortante, es llevado a sacrificar, con todo tipo de rabia, a la primera persona que se ofrece a su vista. (Pinel, 1809: 449)

Para Pinel las pasiones pueden modificar la sensibilidad moral y afectar lo físico. Las pasiones intensas como la cólera, la ira y los arrebatos son perjudiciales para el buen juicio y predisponen a la contracción de la alienación mental o la anuncian. Las emociones intensas pueden

provocar la pérdida de la razón, de ahí que para Pinel las causas morales son las principales en la etiología de la alienación mental:

Esta enfermedad, en ciertos casos, tiene un origen común y se debe desde un comienzo a un acontecimiento o a un concurso de acontecimientos análogos a los que debemos considerar como su causa determinante. Debemos colocar en este número de ejemplos la disposición hereditaria, ciertas afecciones morales fuertes, una pena profunda, un amor contrariado, una exaltación extrema de los principios religiosos, o bien una inmoralidad profunda. (Pinel, 1809: 364)

Las causas morales pueden ser pasiones intensas de todo tipo -prolongadas y contrariadas- y los excesos a todo nivel de la vida humana: irregularidades del modo de vida como la costumbre de la embriaguez, el exceso de los placeres, el abuso del café, etc. (Pinel, 1809). Es importante aclarar que aquí "moral" debe entenderse en el sentido de "psíquico". Pinel incluye entre esas causas morales a la experiencia de pasiones vivas y fuertemente obstruidas, a una manera de vivir desordenada que exalta las facultades mentales, pero también a una temprana educación viciada. Da ejemplos como el siguiente:

Un joven cuya madre había sido alienada fue expuesto, desde su ingreso al mundo, a fuertes contrariedades y penas profundas. Se vuelve desconfiado e irascible en exceso; sus sospechas aumentan y cree ser el blanco de persecuciones de todo género; llega incluso a creer que se burlan de él en panfletos, caricaturas, obras de teatro. Su imaginación se exalta incluso a un mayor grado, está convencido de que luego de haberlo deshonrado en la opinión pública han formado el proyecto atroz de hacerlo morir, y que sus allegados corren el mismo peligro. No le resta más que, según dice, vengarse abiertamente de aquellos a los que llama traidores, monstruos. En ese estado de furor exaltado, sale a la calle y provoca a los transeúntes, y se torna necesaria su reclusión para prevenir algún acontecimiento funesto. (Pinel, 1809: 372).

En 1820 Georget, uno de los primeros alienistas que reivindicó el rol de las perturbaciones cerebrales en la causación de la alienación mental, criticó fuertemente esta concepción etiológica de Pinel en tanto sólo tiene en cuenta los síntomas de la enfermedad y no el trastorno orgánico que las originaría, aunque esa alteración sea aún desconocida.

Las causas de la alienación mental para Pinel incluyen un conjunto bastante heteróclito en el que se mezclan las pasiones exacerbadas, los accidentes que provocan lesiones, la constitución defectuosa y los efectos de una educación inapropiada. Pinel incluye también en su panorama etiológico a las causas físicas y hereditarias, sobre todo en los casos de idiocia y demencia. En éstas, nos advierte el autor, no sería posible llevar a cabo el tratamiento moral por él propuesto, en tanto no se encuentra el resto de razón, necesario e indispensable para el trabajo terapéutico.

Esta diversidad a nivel de la etiología no va a persistir en el paradigma de las enfermedades mentales, en el que veremos cómo se establecen posiciones organicistas más cercanas a la de Georget y más afines a la tesis de la incurabilidad de la locura.

En el paradigma de la alienación mental, esta suposición de las causas morales va de la mano de un **optimismo terapéutico**. Si la enfermedad es provocada por el exceso de las pasiones, un tratamiento que se enfoque a regular y ordenar las mismas es el indicado.¹⁴ Considerar que la alienación mental no se fundamenta en una alteración lesional del cerebro permite suponer su curabilidad. Por esta razón, las manías intermitentes constituyen la mejor prueba de las posibilidades de curación. En la concepción de la alienación mental de Pinel la razón no puede extraviarse por completo, sino que permanece en el enfermo un resto de razón que es esencial para la cura.

El tratamiento moral

El hecho de dejar entre paréntesis la hipótesis etiológica del daño material en el cerebro contribuye a plantear que la alienación mental es curable, puesto que la mente está alterada solamente en su funcionamiento. De esta manera, surge la posibilidad de un tratamiento, ya que para Pinel la alienación nunca es total. El alienado conserva siempre en él una parte de razón. La alienación es una enfermedad "en donde cohabitan la razón y la sin razón" (Álvarez, Esteban & Sauvagnat, 2004: 69). Es sobre este **resto de razón** que se va a asentar la eventual curación. De ahí que para Pinel, la manía periódica, intermitente sea el paradigma de la parcialidad de la alienación.

En este momento, la enfermedad -cuya esencia es inaccesible- es entendida como una reacción saludable del organismo ante la acción de causas que perturban su equilibrio, cuya terminación natural es la cura. El activismo terapéutico queda entonces excluido en favor de no perturbar la evolución del desarrollo natural de la enfermedad y las reacciones del organismo ante ella:

Entonces pensé que era más sabio dejar, en general, que la enfermedad recorriera sus diversos períodos de estado agudo, de declinación y de convalecencia, sin trastornar la marcha de la naturaleza ni intervenir demasiado en ella, variar los medios curativos secundarios según las diversas especies de alienación o el carácter particular de las causas determinantes, pero contar sobre todo con los recursos poderosos de la higiene, estableciendo en el hospicio un orden invariable y en el cual todas las partes estén combinadas de la manera más favorable al reestablecimiento lento y gradual de la razón. (Pinel, 1809: 597).

¹⁴ Ya hemos tratado la organización del asilo como un orden disciplinario en el capítulo 1.

Al ser la alienación mental una afección única, también único era el tratamiento propuesto y las instituciones específicas para tratarla: el asilo. Se trata de devolverle al enfermo la libertad sustraída por la alienación, por medio del aislamiento. Al interior del asilo las distintas especies de los alienados eran separadas: los furiosos y maníacos por un lado, los melancólicos por otro y los dementes e idiotas en otro sector. Así podían asegurarse las condiciones de seguridad necesarias para cada clase.

El **tratamiento moral** incluía tres aspectos fundamentales: el aislamiento, la vigilancia paternal del médico y el trabajo provechoso (Lantéri-Laura, 2000: 81).

El primer paso del tratamiento moral para Pinel consistía en separar al enfermo de sus parientes más próximos e iniciar un **aislamiento terapéutico** en un establecimiento especializado con el fin de proteger al alienado de las influencias perjudiciales de su familia. Al sostener la hipótesis de las causas morales de la alienación, Pinel consideraba que en primer lugar el alienado debía ser alejado del entorno en el que se había producido el exceso y que incluso debían reducirse al máximo las visitas de los familiares una vez internado el enfermo: "Una experiencia ha enseñado que los alienados no pueden casi nunca ser curados en el seno de su familia" (Pinel, 1809: 512).

El aislamiento era entonces la máxima general del tratamiento y debía producirse en una institución perfectamente racional y ordenada, que permitiera apoyarse en el resto de razón del alienado con el fin de reestablecer la razón.

La institución estaba organizada de modo tal de asegurar un orden estricto, constante e invariable, basado en una centralización de la autoridad en la figura del médico. Éste era el encargado de restituir al alienado su razón extraviada a partir del resto de razón existente, contribuyendo a fortalecer las facultades del entendimiento:

Un centro único de autoridad debe estar siempre presente en su imaginación para que aprendan a reprimirse ellos mismos y a dominar su fogosidad impetuosa. Una vez cumplido este objetivo, sólo se trata de ganar su confianza y merecer su estima para devolverlos totalmente al uso de la razón en la declinación de la enfermedad y la convalecencia. Son necesarios, entonces, para estos enfermos, establecimientos públicos o particulares sometidos a reglas invariables de policía interior, y la experiencia diaria muestra de qué manera la más ligera infracción a estas reglas puede volverse perjudicial o incluso peligrosa. (Pinel, 1809: 344).

El asilo imponía un orden infranqueable, sostenido disciplinariamente por todos los miembros (vigilantes, personal de servicio) y concentrado en la figura de **autoridad paternal del médico**. El establecimiento de ese régimen moral y físico debía asegurar la curación. El mantenimiento del orden obedecía a una férrea disciplina y si bien una versión de la historia reconoce a Pinel como el liberador de los alienados, por haber abolido el uso de las cadenas de hierro, el siguiente párrafo muestra bien cómo el aislamiento se basaba en el ejercicio disciplinario sobre los cuerpos:

El supervisor de un hospicio de alienados que ha adquirido ascendente sobre ellos dirige y regula su conducta a su voluntad; debe estar dotado de un carácter firme y desplegar, en la ocasión de ser necesario, un aparato de poder que se imponga; debe amenazar poco, pero ejecutar y si es desobedecido, el castigo debe venir rápidamente, es decir, una reclusión estrecha. (Pinel, 1809: 502).

Por último, Pinel recomendaba como parte del tratamiento moral el ***ejercicio corporal*** y la aplicación de un trabajo mecánico rigurosamente ejecutado, que garantizaba el mantenimiento del orden. El ocio de los alienados sólo contribuía a exacerbar aún más su exaltación. En cambio, la constancia del trabajo podía modificar el curso vicioso del pensamiento y ejercitar las facultades del juicio, contribuyendo así a reestablecer una razón extraviada.

El fundamento del tratamiento moral de Pinel consiste en esta recuperación del predominio de la razón en el alienado a partir de la influencia del médico como representante de la razón. La vía para esta cura es la sugestión, pero también la coacción e incluso el uso de la fuerza física:

[los alienados] pueden estar reducidos a una alteración completa de todas las funciones intelectuales, y sólo obedecer a un impulso ciego que los lleva al desorden y a toda especie de violencias en ese caso, no hay ninguna opinión para dar, y uno debe solamente proveer a la seguridad personal del alienado, así como a la de los otros, y retenerlo simplemente en su celda: si este actúa con una violencia extrema, se puede usar una estrecha camisa de una tela fuerte que debe contener los movimientos de sus pies y sus manos, y fijarlos sobre su cama por fuertes correas que tiene la parte posterior de esta vestimenta y que el alienado no puede percibir. (Pinel, 1809: 474).

Este párrafo de Pinel data del año 1809 y, sin embargo, podemos constatar que el tratamiento de la locura por el aislamiento, la disciplina y la coacción aún existe hoy en día. Los estudios de Goffman sobre los internados en instituciones totales y el informe "Vidas arrasadas" del Centro de estudios legales y sociales confirman que éste no fue un mal del siglo XVIII, sino que ha tenido la potencia suficiente para persistir durante más de dos siglos.

Casos clínicos distintivos del trabajo de los alienistas

Nos interesa para finalizar este recorrido poder transmitir de qué manera los alienistas difundían su práctica. Se puede leer en los casos seleccionados cómo aquellos aspectos fundamentales de la concepción de Pinel organizan el material para su transmisión: los síntomas más notorios, el exceso de las pasiones. De su lectura se puede desprender aquello que intentamos señalar en el curso de lo que hemos desarrollado en este capítulo: la consideración acerca del

síntoma, a cuál le da mayor importancia, el método, el tratamiento y las causas otorgadas a la alienación mental.

Este primer caso corresponde al *Tratado médico-filosófico sobre la alienación mental* de Pinel:

Me han pedido varias veces consejos acerca de la inestabilidad extrema y la variabilidad de carácter de una persona que, desde la más tierna edad, había sido propensa a afecciones cutáneas y a movimientos febriles irregulares. Desde los primeros desarrollos de la razón, había tomado la costumbre de hacer lecturas sin orden ni elección, se ocupaba sucesivamente de novelas, poesías, historia, obras de teatro, que recorría alternativamente con la rapidez del rayo, durante días enteros y gran parte de las noches. Sus períodos menstruales fueron precoces y a menudo estuvieron turbados por penas domésticas profundas y contrariedades repetidas, que explican una irascibilidad extrema, arrebatos, gritos violentos y, a veces, movimientos convulsivos irregulares. La felicidad pareció sonreírle a través de un matrimonio bien avenido; pero conservaba siempre la misma vacilación del carácter y la disposición irresistible a pasar de un extremo al otro. A veces, durante varios días, mostraba agitación continua, hacía compras, se fatigaba hasta el agotamiento; otras veces, presentaba una melancolía sombría, un deseo insalvable de aislarse, un entumecimiento apático y ninguna regla a la hora de la comida ni en la elección de los alimentos. Pasan algunos días sin que ingiera ningún alimento, otros están marcados por un apetito desmesurado que teme no satisfacer y que le provoca a menudo desórdenes de la digestión, y hace abuso de licores alcoholizados. Muchas veces, en el mismo día, pasa bruscamente de una fría apatía a las efusiones de ternura filial, al entusiasmo de la poesía, al fanatismo religioso; a menudo también, trata como juego asuntos importantes o con gravedad y con la más seria atención algunas frivolidades. (...) Finalmente, la alienación más evidente se declara con una singularidad notable. Pasa agitada seis meses al año, corriendo sin cesar para dar a luz proyectos vanos y quiméricos, y los otros seis meses están marcados por un estupor profundo, una sombría desesperación y un impulso muy fuerte al suicidio. (Pinel 1809: 376-377).

Vemos cómo se resaltan en el material los aspectos ligados a los excesos en las pasiones y el desorden de las costumbres que justificarían causalmente la presentación de los síntomas de agitación y depresión. El siguiente caso es una reseña clínica de Jean-Étienne-Dominique Esquirol, discípulo y colaborador de Pinel, quien siguió sus pasos, tanto en los aspectos doctrinales de la psiquiatría, como en los intentos reformadores de la asistencia a los locos.¹⁵

Se trata del caso Señor D:

El señor D., doctor en medicina, de estatura elevada, constitución fuerte, temperamento sanguíneo, la cabeza grande, la frente muy despejada más saliente de

¹⁵ En el capítulo 9, correspondiente a la parte sobre fenómenos elementales de este libro, nos ocuparemos de los aportes de Esquirol al concepto de alucinación.